



GUIA GRATUITO · WEBINÁRIO ITH

Bundles de prevenção de IRAS: **checklists de beira de leito**

Por que cada item está no bundle, o erro da adesão "item a item", indicadores calculados e checklist diário pronto para imprimir.



WEBINÁRIO COM

Esp. Juliana Dias

Embaixadora do MBA em SCIRAS e Segurança do Paciente

O CONCEITO

Bundle é tudo ou nada

Bundle é um conjunto pequeno de práticas baseadas em evidência que, aplicadas **todas juntas e em todos os pacientes**, reduzem a infecção mais do que cada uma isolada. Por isso a adesão é medida no "tudo ou nada": se um item falhou naquele paciente, o bundle não foi cumprido.

CASO ILUSTRATIVO · SITUAÇÃO COMPOSTA A PARTIR DE OCORRÊNCIAS COMUNS, COM DADOS FICTÍCIOS**"Nossa adesão é de 90%", e a infecção não caía**

A UTI apresentava à direção adesão de cerca de 90% a cada item do bundle de cateter central. Mesmo assim, a densidade de infecção de corrente sanguínea não caía. Ao refazer a auditoria no "tudo ou nada", com 25 pacientes avaliados, só 13 tinham todos os itens cumpridos no mesmo dia.

O que falhou: a medida item a item escondia o problema: cada paciente falhava em um item diferente. A adesão real ao bundle era de 52%, não 90%. O item que mais falhava era a revisão diária da necessidade do cateter.

CÁLCULO RESOLVIDO**Item a item x tudo ou nada**

Adesão por item (média): cada item cumprido em ~90% das verificações

Adesão ao bundle = pacientes com todos os itens ÷ pacientes auditados × 100 = $13 \div 25 \times 100 = 52\%$

Densidade de IPCS = 3 infecções ÷ 850 cateteres-dia × 1.000 = **3,5 por 1.000 cateteres-dia**

Leitura: apresente sempre os dois números lado a lado, mês a mês. Quando a adesão no tudo ou nada sobe e a densidade cai, o gráfico convence a direção sozinho.

OS QUATRO BUNDLES

Itens e por quê

Bundle	Itens principais	Por que funcionam
Cateter venoso central (IPCS)	Inserção: higiene das mãos; barreira máxima (gorro, máscara, avental e luvas estéreis, campo amplo); clorexidina alcoólica > 0,5%; evitar femoral em adultos; checklist com poder de interromper. Manutenção: revisão diária da necessidade; desinfecção de conectores antes de cada acesso; curativo íntegro (gaze até 48 h, filme até 7 dias).	Na inserção, a contaminação vem da pele e do campo; depois, dos conectores manipulados. Tirar o cateter desnecessário elimina o risco na origem.
Ventilação mecânica (PAV)	Cabeceira entre 30° e 45°; interrupção diária da sedação e avaliação de extubação; higiene oral conforme protocolo; pressão do cuff em geral entre 25 e 30 cmH ₂ O; aspiração subglótica quando disponível; não trocar circuito de rotina.	A PAV vem da aspiração de secreções da boca e da orofaringe. Cabeceira elevada e cuff adequado reduzem a aspiração; menos dias de ventilação reduzem a exposição.
Sonda vesical (ITU)	Só com indicação registrada; técnica asséptica na inserção; sistema fechado sem desconexões; bolsa abaixo da bexiga e sem tocar o chão; retirada o quanto antes.	Cada dia de sonda aumenta o risco. Sistema fechado e fluxo livre impedem a subida de bactérias pela sonda.
Sítio cirúrgico (ISC)	Banho pré-operatório; sem tricotomia (ou tricotomizador elétrico imediatamente antes, nunca lâmina); profilaxia antibiótica até 60 min antes da incisão, quando indicada; clorexidina alcoólica; controle glicêmico; normotermia.	A lâmina causa microlesões colonizáveis; a profilaxia precisa estar no tecido no momento da incisão; hiperglicemia e hipotermia prejudicam a defesa.

ERROS MAIS COMUNS

- ☐ Medir adesão item a item e chamar de "adesão ao bundle"
- ☐ Profilaxia cirúrgica administrada já na sala, depois da incisão
- ☐ Auditar só a inserção e esquecer a manutenção diária
- ☐ Bolsa coletora pendurada na grade da cama, acima da bexiga

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Checklist diário de manutenção dos dispositivos

Setor: _____ Data: _____ Leito: _____

Responsável: _____

Cateter venoso central		Sim	Não
1	Necessidade do cateter revisada hoje e registrada	☐	☐
2	Curativo íntegro, limpo e dentro do prazo de troca	☐	☐
3	Conectores desinfetados antes de cada acesso (observado)	☐	☐
Ventilação mecânica		Sim	Não
4	Cabeceira entre 30° e 45°	☐	☐
5	Interrupção da sedação / avaliação de extubação feita hoje	☐	☐
6	Pressão do cuff aferida e dentro da faixa	☐	☐
7	Higiene oral realizada conforme protocolo	☐	☐
Sonda vesical de demora		Sim	Não
8	Indicação da sonda revisada hoje e registrada	☐	☐
9	Sistema fechado, sem desconexões	☐	☐
10	Bolsa abaixo da bexiga, sem tocar o chão, com fluxo livre	☐	☐

Bundle cumprido no dispositivo = todos os itens "Sim". Adesão do dia = dispositivos com bundle cumprido ÷ dispositivos avaliados × 100 = ____ %.



PRÓXIMO PASSO

Quer aprofundar este tema ao vivo?

Este guia resume os pontos centrais. No webinar gratuito com a Esp. Juliana Dias, você vê os exemplos da rotina e tira suas dúvidas no chat.

Webinário gratuito: Bundles de prevenção de IRAS

Online e ao vivo. Inscreva-se e receba a data e o link no WhatsApp e no e-mail.

Quero me inscrever grátis

mkt.faculdadeith.com.br/lp/webinario-bundles-iras/

MBA em SCIRAS e Segurança do Paciente - 100% EAD

Controle de infecção, gestão de riscos, acreditação e núcleo de segurança do paciente. 440 horas, diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5).

Conhecer o MBA

Fontes

- ANVISA. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde.
- ANVISA. Critérios Diagnósticos de IRAS.
- Institute for Healthcare Improvement (IHI). How-to Guides: Prevent Central Line-Associated Bloodstream Infections; Prevent Ventilator-Associated Pneumonia.
- OMS. Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection.